Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

# Chute

Personne au sol ou chute observée (adulte, personne en fauteuil, enfant) : évaluer avant de relever, alerter, tracer.

**URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT** · ne répond pas ou respire mal, saignement abondant, douleur du cou avec fourmillements, malaise ou douleur thoracique avant la chute.

## 1 · Je sécurise

- **Ne pas relever tout de suite** : parler, observer, couvrir si le sol est froid.
- Douleur du cou ou du dos : **ne pas bouger la tête**, ne pas asseoir.
- **Relever seulement après accord de l'IDE** (sur place ou d'astreinte), à deux ou au lève-personne.
- Chute du fauteuil : freins, appareillage ; ne pas réinstaller si douleur.

## 2 · J'observe et je mesure

- Réagit-elle comme d'habitude ? Respire-t-elle bien ?
- Pouls, TA, SpO2 ; glycémie capillaire si diabète (AS/AP).
- Choc à la tête ? Plaie ? Membre déformé ?
- **Temps passé au sol ?** Paralysie : fracture possible sans douleur.
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** (Kardégic, Plavix, Eliquis, Xarelto...).

## 3 · J'agis

- Après accord : relever, installer, sonnette à portée ; prévenir l'IDE **même si tout va bien**.
- Plaie → « Plaie simple » ; choc à la tête → « Traumatisme crânien ».
- Bosse : froid 10 min dans un linge.
- Enfant (IME) : prévenir les parents selon le PAI.
- Déclarer la chute (procédure de l'établissement).

## Je ne fais pas

- Relever une personne qui a mal à la hanche, au cou ou au dos, ou ne bouge pas un membre.
- Faire boire ou manger une personne confuse ou somnolente.
- Donner un antalgique « si besoin » sans validation de l'IDE (ou du médecin d'astreinte).
- Laisser seule une personne qui s'est cogné la tête sous anticoagulant ou antiagrégant.

## J'alerte

**Appel 15 immédiat si :**

- Choc à la tête sous **anticoagulant** ou sous **deux antiagrégants**.
- Après choc à la tête : somnolence, confusion nouvelle, plus d'un vomissement, convulsion.
- Hanche douloureuse avec jambe raccourcie ou tournée ; enfant mou, inconsolable ou somnolent.
- Signe de gravité et IDE non joignable tout de suite.

**J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :**

- Choc à la tête, **65 ans ou plus sous un antiagrégant** : avis médical sans délai (scanner dans les 8 h).
- **Au sol plus d'1 h**, douleur, boiterie, plaie, gros hématome.
- Pouls < 50 ou > 120/min, PAS < 100 mmHg, SpO2 < 90 %, glycémie < 0,70 g/L.
- Chute sans témoin ou 2e chute rapprochée.

## Je surveille et je trace

- Tracer : heure, circonstances, témoin, temps au sol, constatations, paramètres, qui a été prévenu.
- Douleur, boiterie, hématome ou comportement inhabituel dans les 48 h : prévenir l'IDE (fracture possible).
- Chute répétée : le signaler pour réévaluer la prévention (chaussage, vue, médicaments, aides).

## Mention de sécurité

On évalue avant de relever, on relève après accord. Choc à la tête sous anticoagulant ou deux antiagrégants = 15 ; 65 ans ou plus sous antiagrégant = avis médical sans délai.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées (2009) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; ARS IDF/STARAQS, Situations d'urgence en ESMS handicap, fiche Chute (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiche 0 (2016) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES, art. 2).

Réf. DOTR-AS-CHUTE | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature